

Vitiligo

(Basado en: Guía Clínica MINSAL Chile 2023, American Academy of Dermatology 2024, British Association of Dermatologists Guidelines 2023, Fitzpatrick's Dermatology 2023, y UpToDate 2025).

1. Introducción y relevancia clínica

El **vitiligo** es una **enfermedad cutánea autoinmune crónica** caracterizada por la **pérdida progresiva de melanocitos**, lo que resulta en **máculas acrómicas (blancas)** bien delimitadas en la piel.

Afecta aproximadamente al **1–2% de la población mundial**, sin predilección por sexo ni raza.

Importancia clínica

- No causa morbilidad física directa, pero su **impacto psicológico y social** puede ser considerable.
- Puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, como **tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1 o anemia perniciosa**.
- En EUNACOM, es esencial reconocer su **fisiopatología inmunológica, diagnóstico clínico y terapéutica escalonada**.

Tipos principales

- **Vitiligo generalizado (no segmentario)**: forma más frecuente; lesiones bilaterales y simétricas.
 - **Vitiligo segmentario**: unilateral, sigue una distribución dermatomal o blaschkoide, de curso más estable.
 - **Vitiligo focal o localizado**: pocas lesiones sin patrón claro.
 - **Vitiligo universal**: afecta más del 80% de la superficie corporal.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El vitiligo resulta de una **interacción multifactorial** entre **factores genéticos, autoinmunes y ambientales** que culminan en la destrucción selectiva de los melanocitos epidérmicos.

2.1. Mecanismos inmunológicos

- **Autoinmunidad celular:** los linfocitos T CD8+ citotóxicos atacan melanocitos expresando antígenos propios (tirosinasa, gp100, MART-1).
- **Autoinmunidad humoral:** anticuerpos antimelanocito contribuyen al daño adicional.
- **Citocinas implicadas:** IFN- γ , TNF- α e IL-17 promueven apoptosis melanocitaria.

Este proceso se autoperpetúa por la liberación de **DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns)** y radicales libres.

2.2. Factores predisponentes

- **Genéticos:** asociación con HLA-A2, HLA-DR4 y genes del sistema inmunitario (NLRP1, PTPN22).
 - **Ambientales:** trauma cutáneo, quemaduras, estrés emocional, exposición solar intensa.
 - **Fenómeno de Koebner:** aparición de nuevas lesiones en zonas de trauma o fricción.
 - **Asociaciones autoinmunes:**
 - Tiroiditis autoinmune.
 - Diabetes mellitus tipo 1.
 - Anemia perniciosa.
 - Alopecia areata.
-

2.3. Fisiopatología del color

El color normal de la piel depende de la presencia y actividad de melanocitos.

En el vitiligo:

- Hay **ausencia total de melanocitos funcionales** en la epidermis afectada.
 - La piel se torna **blanca nacarada**, sin alteración de la textura ni descamación.
 - El pelo en la zona afectada puede volverse **blanco (leucotriquia)**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Lesiones características

- **Máculas acrómicas** (blancas) bien delimitadas, de bordes nítidos o hiperpigmentados.
 - Pueden confluir y formar áreas extensas de despigmentación.
 - Las lesiones no son pruriginosas ni descamativas.
 - **Pelo blanco** dentro de la lesión (leucotriquia) sugiere daño folicular profundo.
 - **Fenómeno de Koebner positivo**: nuevas lesiones en sitios de trauma repetido.
-

3.2. Distribución típica

- Periorificial (alrededor de boca, ojos, genitales y ombligo).
 - Dorso de manos, codos, rodillas, pies y zonas expuestas al sol.
 - Segmentaria: unilateral, respetando la línea media.
 - Universal: compromiso casi completo de la piel.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Enfermedad

Características distintivas

Pitiriasis alba	Máculas hipopigmentadas mal definidas, descamativas, en niños
Tiña versicolor	Máculas hipocrómicas con fina descamación, KOH positivo
Lepra indeterminada	Hipopigmentación con anestesia cutánea y pérdida de vello
Hipomelanosis postinflamatoria	Antecedente de dermatitis o trauma
Esclerosis tuberosa	Máculas hipomelanóticas desde la infancia

3.4. Evolución

- Curso **crónico y fluctuante**, con periodos de progresión y remisión.
 - Puede estabilizarse espontáneamente o extenderse rápidamente.
 - En el vitiligo segmentario, suele estabilizarse en 6–24 meses.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico**, basado en:

1. Presencia de máculas acrómicas bien delimitadas.
2. Distribución típica y fenómeno de Koebner.
3. Luz de Wood: fluorescencia blanco-azulada brillante.

- 4. Ausencia de descamación o inflamación.

4.2. Exámenes complementarios

Examen	Hallazgo	Indicación
Luz de Wood (365 nm)	Resalta máculas blanquecinas con bordes nítidos	Confirmar extensión o lesiones subclínicas
Biopsia de piel (raro)	Ausencia total de melanocitos	Casos atípicos
Perfil tiroideo (TSH, anti-TPO)	Detección de tiroiditis autoinmune	En todo paciente con vitiligo
Glicemia / HbA1c	Descartar diabetes tipo 1	Si sospecha
Vitamina B12 / folato	Asociaciones autoinmunes	Según clínica

4.3. Criterios diagnósticos (AAD, 2024)

- 1. Máculas acrómicas bien delimitadas, no descamativas.
- 2. Realce bajo luz de Wood.
- 3. Ausencia de melanocitos en biopsia (confirmatorio).
- 4. Fenómeno de Koebner o leucotriquia.
- 5. Exclusión de otras causas de hipopigmentación.

Diagnóstico confirmado: criterios 1 + 2 + exclusión diferencial.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

El manejo se orienta a **detener la progresión, estimular la repigmentación y brindar apoyo psicológico**.

5.1. Educación y medidas generales

- Explicar la naturaleza benigna y autoinmune del cuadro.
- Uso diario de **fotoprotector FPS ≥ 50** (la piel acrómica es fotosensible).
- Camuflaje cosmético o micropigmentación en áreas visibles.
- Evitar traumas repetidos (cinturones, depilación, presión mecánica).
- Apoyo psicológico y grupos de pacientes.

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Tópico (primera línea en lesiones localizadas)

Fármaco	Mecanismo	Indicaciones
Corticoides tópicos potentes (betametasona, mometasona)	Inmunosupresión local	Lesiones recientes o extensas
Inhibidores de calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus)	Modulan respuesta de linfocitos T	Áreas sensibles (cara, cuello, genitales)
Vitamina D3 (calcipotriol)	Estimula diferenciación melanocítica	Terapia combinada

Duración: 2–3 meses, con control mensual de efectos adversos (atrofia, telangiectasias).

B. Fototerapia (segunda línea)

- **NB-UVB (luz ultravioleta B estrecho, 311 nm):**

- Tratamiento estándar en vitiligo extenso (>20% de superficie corporal).
- Sesiones 2–3 veces por semana durante 6–12 meses.
- Estimula migración y proliferación de melanocitos residuales.
- Respuesta mejor en cara y tronco, peor en extremidades distales.
- **Excimer láser (308 nm):** alternativa localizada, especialmente útil en vitiligo segmentario o facial.

C. Terapia sistémica

- **Corticoides orales (mini-pulsos):** prednisona 0,3–0,5 mg/kg por 2 días/semana durante 3 meses, para detener progresión rápida.
- **JAK-inhibidores (tofacitinib, ruxolitinib):** inhiben señalización de IFN- γ ; prometedores en ensayos clínicos (aún no disponibles en red pública).
- **Antioxidantes (vitamina E, polipodium leucotomos):** adyuvantes con fototerapia.

D. Cirugía (tercera línea, lesiones estables >1 año)

- **Autoinjertos de piel o melanocitos:** microinjertos, injertos por succión o suspensiones celulares.
- Indicada en vitiligo estable, especialmente segmentario o postraumático.

5.3. Tratamiento integral (según extensión)

Extensión	Manejo recomendado
Localizado <10%	Corticoide o tacrolimus tópico
Extenso >10%	Fototerapia NB-UVB $\pm$ tópicos

Rápida progresión Corticoide sistémico corto

Refractario Injertos o láser excimer
estable

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Fotosensibilidad	Mayor riesgo de eritema o quemadura solar
Alteraciones psicológicas	Ansiedad, depresión, baja autoestima
Enfermedades autoinmunes	Tiroiditis, DM1, anemia perniciosa, lupus
Leucotriquia persistente	Peor respuesta terapéutica
Hiperpigmentación periférica	Post-tratamiento (efecto rebote local)

Pronóstico:

- Variable: 40–60% mejora parcial con tratamiento.
 - Cara y tronco responden mejor que extremidades.
 - El vitiligo segmentario tiene curso autolimitado y responde poco a inmunoterapia.
 - No existe cura definitiva, pero la **fototerapia + tacrolimus** logra estabilización prolongada.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Máculas blancas bien delimitadas, sin descamación + luz de Wood positiva = Vitiligo.**
 2. **Vitiligo no descama y no pica** (clave diferencial con tiña o dermatitis).
 3. **Corticoides tópicos y tacrolimus** son primera línea en lesiones recientes.
 4. **Fototerapia NB-UVB** es el estándar para enfermedad extensa.
 5. **Asociación frecuente con tiroiditis autoinmune** → solicitar TSH y anti-TPO.
 6. **Fenómeno de Koebner positivo**: nuevas lesiones en zonas traumatizadas.
 7. **En EUNACOM**, el distractor más común es la **pitiriasis versicolor** (descamativa y con hipopigmentación, no acrómica).
-



Errores comunes

- Usar **corticoides potentes en cara o genitales** sin control (riesgo de atrofia).
 - No evaluar enfermedades autoinmunes asociadas.
 - Confundir vitiligo con infecciones fúngicas o lepra indeterminada.
 - Suspender tratamiento prematuramente (requiere meses para respuesta).
 - No ofrecer apoyo psicológico o camuflaje cosmético.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **vitiligo** es una **enfermedad autoinmune** caracterizada por la **destrucción de melanocitos**, generando máculas acrómicas bien delimitadas.

2. El **diagnóstico es clínico**, apoyado por **luz de Wood** y **serología tiroidea**.
3. El **tratamiento inicial** es con **corticoides o tacrolimus tópicos** y **fototerapia NB-UVB** en formas extensas.
4. Los **factores autoinmunes (tiroiditis, DM1)** deben pesquisarse sistemáticamente.
5. El **fenómeno de Koebner** y la **leucotriquia** son hallazgos típicos.
6. No causa síntomas físicos, pero tiene **gran impacto psicológico**, que requiere abordaje integral.
7. En EUNACOM, la clave diagnóstica es **mácula blanca bien delimitada, sin descamación, luz de Wood positiva y asociación autoinmune**.